

INSTITUICAO: _____

PARECER — CUIDADOS PALIATIVOS

DATA: ____ / ____ / _____ HORA: ____ : ____

I. IDENTIFICACAO

PACIENTE: _____
IDADE: _____
LEITO / SETOR: _____
MEDICO SOLICITANTE: _____
DIAGNOSTICO PRINCIPAL: _____
DATA DA SOLICITACAO: _____

II. RESUMO CLINICO

PACIENTE _____, _____ ANOS, PORTADOR DE _____, DIAGNOSTICADO EM
_____. SUBMETIDO A _____, ADMITIDO EM _____ POR
_____. APRESENTA _____ NO _____ MOMENTO
_____.

III. AVALIACAO PALIATIVA

A. ESCALA DE PERFORMANCE:

ESCALA	VALOR ESTIMADO
ECOG	0 / 1 / 2 / 3 / 4
KPS	_____ %
DEPENDENCIA FUNCIONAL	INDEPENDENTE / PARCIAL / TOTAL

B. FASE DA DOENCA:

- ☐ FASE INICIAL — DOENCA ATIVA COM TRATAMENTO MODIFICADOR EM CURSO
- ☐ FASE DE PROGRESSAO — TRATAMENTO ATIVO COM RESPOSTA INSATISFATORIA
- ☐ FASE AVANCADA — ESGOTAMENTO DAS OPCOES CURATIVAS
- ☐ FASE TERMINAL — PROGNOSTICO DE DIAS A SEMANAS

C. GRAU DE PALIACAO:

- ☐ CUIDADOS PALIATIVOS SIMULTANEOS AO TRATAMENTO ONCOLOGICO ATIVO
- ☐ CUIDADOS PALIATIVOS PREDOMINANTES COM TRATAMENTO ATIVO RESIDUAL
- ☐ CUIDADOS PALIATIVOS EXCLUSIVOS — SEM TRATAMENTO MODIFICADOR DE DOENCA
- ☐ CUIDADOS DE CONFORTO — FASE FINAL DE VIDA

D. PROGNOSTICO ESTIMADO:

- ☐ MESES A ANOS
- ☐ SEMANAS A MESES
- ☐ DIAS A SEMANAS
- ☐ HORAS A DIAS

IV. AVALIACAO DE SINTOMAS

DOMINIO	PRESENTE	INTENSIDADE	CONTROLADO
---------	----------	-------------	------------

DOR	SIM / NAO	LEVE / MOD / GRAVE	SIM / NAO
NAUSEA / VOMITO	SIM / NAO	LEVE / MOD / GRAVE	SIM / NAO
DISPNEIA	SIM / NAO	LEVE / MOD / GRAVE	SIM / NAO
AGITACAO / DELIRIUM	SIM / NAO	LEVE / MOD / GRAVE	SIM / NAO
CONSTIPACAO	SIM / NAO	LEVE / MOD / GRAVE	SIM / NAO
INSONIA	SIM / NAO	LEVE / MOD / GRAVE	SIM / NAO
FADIGA	SIM / NAO	LEVE / MOD / GRAVE	SIM / NAO
ANSIEDADE / DEPRESSAO	SIM / NAO	LEVE / MOD / GRAVE	SIM / NAO
OUTROS	SIM / NAO	LEVE / MOD / GRAVE	SIM / NAO

V. RECOMENDACOES — CONTROLE DE SINTOMAS

A. DOR:

LEVE: DIPIRONA / PARACETAMOL | MODERADA: TRAMADOL / CODEINA | GRAVE: MORFINA — DOSE ____MG, VIA ____, INTERVALO ____H, RESGATE ____MG A CADA ____H. ESCALA COMPORTAMENTAL (PAINAD/ABBEY) SE PACIENTE SEM COMUNICACAO VERBAL.

B. NAUSEAS / VOMITOS:

BROMOPRIDA ____MG ____/____H / ONDANSETRONA ____MG ____/____H / HALOPERIDOL ____MG SC ____/____H (NAUSEA CENTRAL) / DEXAMETASONA (COMPONENTE INFLAMATORIO / HIC).

C. DISPNEIA:

MORFINA 2-5MG SC A CADA 4H | OXIGENIOTERAPIA SE CONFORTO | EVITAR HIPERHIDRATAACAO.

D. AGITACAO / DELIRIUM:

HALOPERIDOL 1-2MG SC/IV ____/____H + RESGATE ____MG A CADA 30MIN. SEDACAO PALIATIVA SE REFRATARIO: MIDAZOLAM 5-10MG SC/IV EM INFUSAO CONTINUA.

E. CONVULSOES:

MANTER ANTIEPILETICO: _____. PROTOCOLO DE RESGATE: DIAZEPAM 10MG IV / MIDAZOLAM 5-10MG SC. DISPONIVEL A BEIRA LEITO.

F. CONSTIPACAO:

LACTULOSE 15-30ML 8/8H VIA SNE/VO. BISACODIL SE IMPACTACAO.

G. ANSIEDADE / INSONIA:

CLONAZEPAM 0,5-2MG VO/SNE A NOITE. MIDAZOLAM SC SE VIA ORAL INDISPONIVEL.

H. HIDRATAACAO E NUTRICAO:

AVALIAR PROPORCIONALIDADE. REDUZIR METAS CALORICA EM FASE TERMINAL. HIPERHIDRATAACAO PODE AGRAVAR EDEMA E SECRECOES — REAVALIAR.

I. CUIDADOS GERAIS:

MUDANCA DE DECUBITO 2/2H | HIGIENE ORAL FREQUENTE | CUIDADOS COM MUCOSAS, OLHOS E PELE | AMBIENTE TRANQUILO | PRESENCA FAMILIAR ESTIMULADA.

VI. LIMITACAO DE SUPORTE DE VIDA

- NAO REANIMAR (DNR) EM CASO DE PCR
- NAO INTUBAR / NAO VENTILAR INVASIVAMENTE
- NAO TRANSFERIR PARA UTI COM FINALIDADE CURATIVA
- NAO INICIAR NOVOS PROCEDIMENTOS SEM IMPACTO NO CONFORTO
- NAO INICIAR DIALISE / SUPORTE DE ORGAOS
- SUSPENDER MEDICAMENTOS SEM BENEFICIO PALIATIVO
- OUTRA: _____

ESTAS DIRETRIZES DEVEM SER REGISTRADAS EM PRONTUARIO E COMUNICADAS A TODA A EQUIPE ASSISTENCIAL E DE ENFERMAGEM.

VII. COMUNICACAO COM A FAMILIA

CONFERENCIA FAMILIAR: REALIZADA / NAO REALIZADA / AGENDADA: ____/____/____

PARTICIPANTES:

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| ■ MEDICO ASSISTENTE | ■ EQUIPE DE ENFERMAGEM |
| ■ ASSISTENCIA SOCIAL | ■ PSICOLOGIA |
| ■ CAPELANIA / APOIO ESPIRITUAL | ■ OUTROS: _____ |

PONTOS ABORDADOS:

- DIAGNOSTICO E GRAVIDADE DA DOENCA
- PROGNOSTICO E LIMITACAO DO TRATAMENTO CURATIVO
- OBJETIVO DO CUIDADO ATUAL — CONFORTO E DIGNIDADE
- DIRETRIZES ANTECIPADAS E LIMITACAO DE SUPORTE DE VIDA
- O QUE ESPERAR NA TRAJETORIA FINAL — SINAIS DE MORTE IMINENTE
- PARTICIPACAO DA FAMILIA NO CUIDADO E ESTIMULO A PRESENCA
- SUPORTE AO LUTO — DURANTE INTERNACAO E APOS O OBITO

REACAO DA FAMILIA:

- COMPREENSAO ADEQUADA
- DIFICULDADE DE ACEITACAO — NECESSITA NOVA ABORDAGEM
- CONFLITO FAMILIAR — SOLICITAR APOIO SOCIAL / JURIDICO
- SOLICITACAO DE SEGUNDA OPINIAO

VIII. ENCAMINHAMENTOS

- PSICOLOGIA — SUPORTE AO PACIENTE E FAMILIA
- ASSISTENCIA SOCIAL — SUPORTE FAMILIAR E PLANEJAMENTO DE ALTA
- FISIOTERAPIA — CONFORTO RESPIRATORIO E POSICIONAMENTO
- FONOAUDIOLOGIA — AVALIACAO DE DEGLUTICAO SE APLICAVEL
- CAPELANIA / APOIO ESPIRITUAL — SE DESEJO DA FAMILIA
- CUIDADOS PALIATIVOS DOMICILIARES — SE VIAVEL

IX. CONCLUSAO

PACIENTE EM _____, FASE _____, COM SINTOMAS PRINCIPAIS DE _____. AS MEDIDAS TERAPEUTICAS DEVEM SER ORIENTADAS PARA _____. RECOMENDA-SE _____. DIRETRIZES ANTECIPADAS: REGISTRADAS / A REGISTRAR. CONFERENCIA FAMILIAR: REALIZADA / AGENDADA.

EQUIPE DE CUIDADOS PALIATIVOS DISPONIVEL PARA REAVALIACAO CONFORME NECESSIDADE.

MEDICO PALIATIVISTA / CRM

MEDICO SOLICITANTE / CRM
